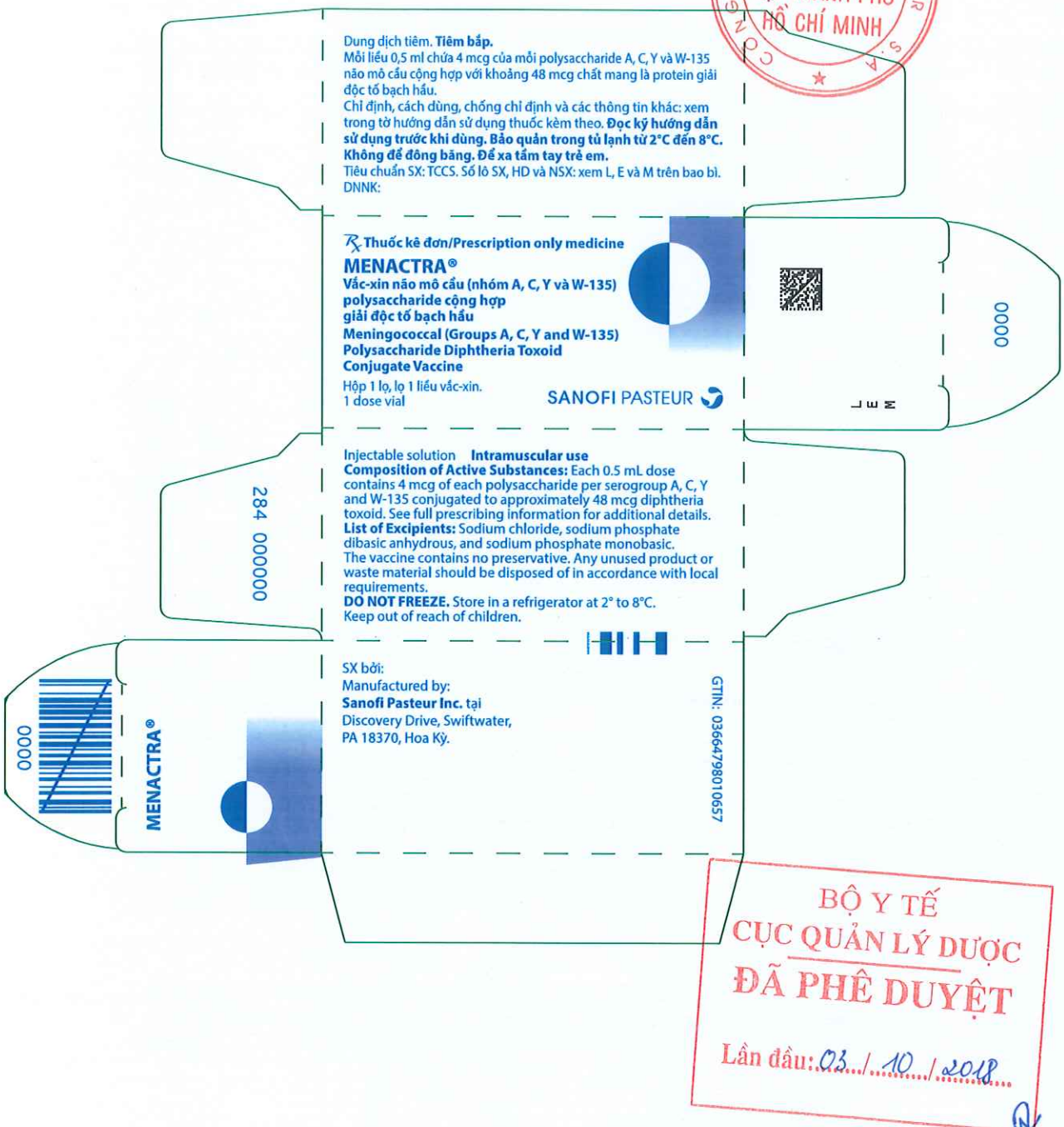
STT: 01/GĐ: 690/GĐ-QLD / QLVX-H03-1111-18 / ĐĐ136
03/10/2018

Template last updated on 06Jun2008

MENACTRA®
1 Dose Vial - Vietnam

Text / Bar Codes / SP Logo – PMS Reflex BlueC
Half Circle – PMS Reflex BlueC
Gradient Bar – PMS 2577C
Size: 1-3/16 x 1-3/16 x 2-3/8"
Spec Part # D000006
SAP Part # 000000
Folding Carton / Package Label
284 FG0000 V2 VN 1x1 02May18
Version 2 MB



VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 03/10/2018

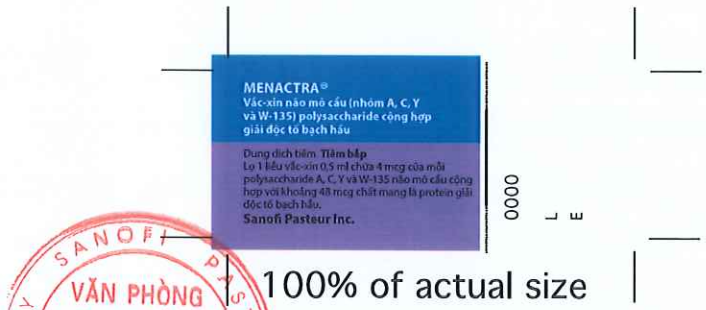
Template updated on 08 Dec 2011

Text / Logo – Black*

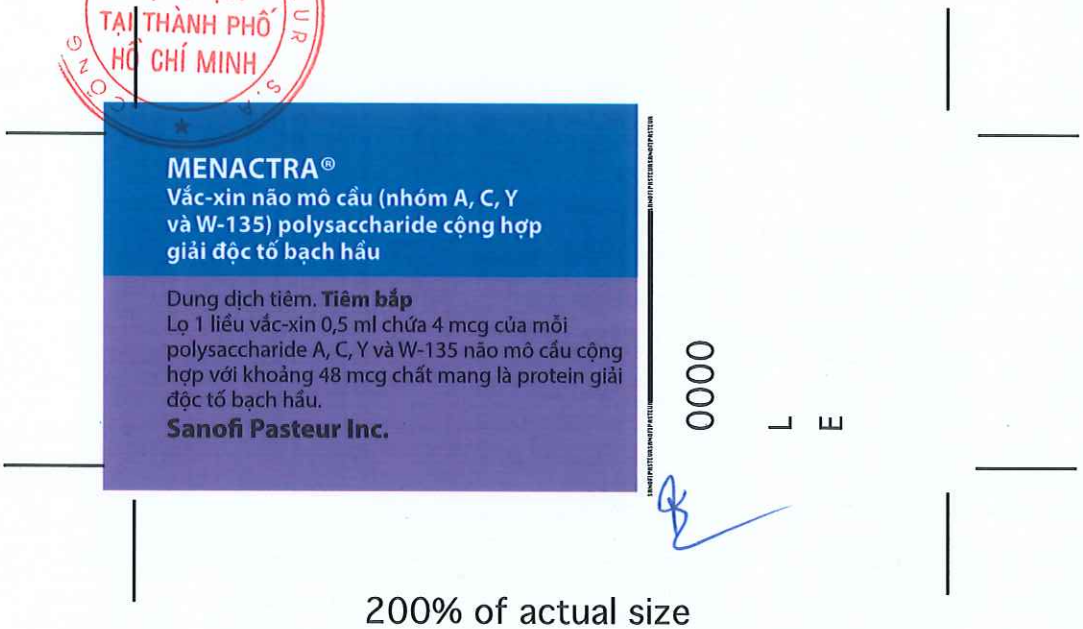
MENACTRA®
1 Dose Vial Label - Vietnam

Top Bar – PMS Reflex BlueC*
Bottom Bar – PMS 2577C*
Size: 2 x 13/16"
SAP Part # TBD
Spec Part # D000016
Vial Label (3 mL) / Container Label
284 LT0000 V2 VN 1D 02May18
Version 2 MB

* Print colors may not match actual PMS colors - Please see PMS color book for precise color



100% of actual size



200% of actual size

℞ **Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc**

Menactra®

Vắc-xin não mô cầu (nhóm A, C, Y và W-135) polysaccharide cộng hợp giải độc tố bạch hầu

Dung dịch tiêm. TIÊM BẮP

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng vắc-xin.

THÀNH PHẦN

Trong 1 liều 0,5 ml vắc xin:

Thành phần hoạt chất:

- Polysaccharide Não mô cầu (nhóm huyết thanh A) (đơn giá cộng hợp) .....4 mcg
- Polysaccharide Não mô cầu (nhóm huyết thanh C) (đơn giá cộng hợp) .....4 mcg
- Polysaccharide Não mô cầu (nhóm huyết thanh Y) (đơn giá cộng hợp) .....4 mcg
- Polysaccharide Não mô cầu (nhóm huyết thanh W-135) (đơn giá cộng hợp).....4 mcg
- Protein giải độc tố Bạch hầu .....48 mcg*
  (Protein mang cộng hợp polysaccharide đối với tất cả các nhóm huyết thanh)

  ** Lượng giải độc tố bạch hầu là lượng ước tính và phụ thuộc vào tỉ số giữa polysaccharide cộng hợp và protein*

Thành phần tá dược: sodium chloride, sodium phosphate dibasic anhydrous, sodium phosphate monobasic monohydrate crystal.

DẠNG BÀO CHẾ

Dạng lỏng. Dung dịch tiêm vô khuẩn không có chất bảo quản.

CHỈ ĐỊNH

Menactra được chỉ định để tạo miễn dịch chủ động cơ bản và nhắc lại phòng bệnh xâm lấn do *N. meningitidis* (Não mô cầu) các nhóm huyết thanh A, C, Y và W-135 gây ra. Menactra được chỉ định để sử dụng ở người từ 9 tháng đến 55 tuổi.

Menactra không được dùng để điều trị bệnh do nhiễm Não mô cầu.

Menactra không được sử dụng để điều trị viêm màng não. Menactra không được chỉ định để chống lại bệnh bạch hầu.

LIỀU DÙNG VÀ PHÁC ĐỒ SỬ DỤNG

Liều dùng của Menactra là 0,5 ml bằng đường tiêm bắp.

Tiêm chủng cơ bản:

- Trẻ em 9 đến dưới 24 tháng tuổi: Menactra được tiêm 2 liều cách nhau ít nhất 3 tháng.
- Người 2 đến 55 tuổi: tiêm một liều.

Tiêm chủng nhắc lại:

- Có thể tiêm một liều nhắc lại cho người từ 15 đến 55 tuổi tiếp tục có nguy cơ mắc bệnh do não mô cầu, nếu liều vắc-xin trước đây được tiêm ít nhất đã 4 năm.

ĐƯỜNG DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DÙNG

Tiêm một liều 0,5 ml Menactra bằng đường tiêm bắp, tốt nhất là tiêm ở mặt trước-ngoài của đùi hoặc vùng cơ delta tùy theo tuổi và khối cơ của đối tượng.

Không được tiêm tĩnh mạch.

Tránh tiêm vắc-xin trong da hoặc dưới da vì chưa có các nghiên cứu lâm sàng chứng minh tính an toàn và hiệu lực của vắc-xin khi sử dụng những đường này.

CHUẨN BỊ VÀ CÁCH DÙNG

Menactra là sản phẩm dạng lỏng trong suốt đến hơi đục, trong lọ một liều không có chất bảo quản. Trước khi dùng, phải quan sát kiểm tra vắc-xin về các hạt lạ và/ hoặc sự thay đổi hình thức cảm quan. Không được dùng nếu có những thay đổi như vậy. Bảo quản trong tủ lạnh cho đến khi sử dụng.

Chuẩn bị

Lọ: tháo nắp lấy và dùng một bơm tiêm và kim thích hợp, rút 0,5 ml sản phẩm, bảo đảm không có bọt khí trước khi tiêm.

Tiêu hủy

Sau khi dùng, lượng vắc-xin còn lại và lọ chứa phải được tiêu hủy một cách an toàn, tốt nhất là bất hoạt bằng nhiệt hoặc thiêu, theo qui trình được chấp thuận ở địa phương.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn: Đã biết bị phản ứng quá mẫn toàn thân với bất kỳ thành phần nào của Menactra (như đã ghi trong **"THÀNH PHẦN"** và **"CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG"**) hoặc sau một lần tiêm vắc-xin này hoặc một vắc-xin chứa cùng một thành phần trước đây.

Sốt hay bệnh cấp tính: Thông thường, trong trường hợp sốt vừa hoặc nặng và/ hoặc bệnh cấp tính nên trì hoãn chủng ngừa và sốt nhẹ không được xem là chống chỉ định.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

Không được tiêm vào mạch máu: phải bảo đảm kim tiêm không xuyên vào mạch máu.

- **Hội chứng Guillain-Barré (GBS)**

Người trước đây đã được chẩn đoán có hội chứng Guillain-Barré (GBS) có thể tăng nguy cơ bị GBS sau khi tiêm Menactra. Cần lưu ý đến các lợi ích và nguy cơ tiềm tàng khi quyết định dùng Menactra.

GBS được báo cáo có liên quan về mặt thời gian sau khi tiêm Menactra. Nguy cơ GBS sau tiêm Menactra đã được đánh giá trong một nghiên cứu thuần tập hồi cứu hậu mãi (Xem phần Dữ liệu hậu mãi).

- **Ngăn ngừa và kiểm soát các phản ứng dị ứng Vắc-xin**

Trước khi tiến hành tiêm ngừa, các nhân viên y tế nên xem xét lịch sử sự tạo miễn dịch của sự nhạy cảm vắc-xin và các phản ứng phụ liên quan đến sự tiêm ngừa trước đó để cho phép đánh giá giữa lợi ích và nguy cơ. Khi các phản ứng quá mẫn cấp tính xảy ra, phải luôn sẵn có ngay lập tức Epinephrine và các chất thích hợp để kiểm soát các phản ứng dị ứng tức thì.

- **Biến đổi khả năng miễn dịch**

Giảm đáp ứng miễn dịch

Một vài đối tượng có thể biến đổi khả năng miễn dịch, bao gồm những đối tượng nhận các phương pháp trị liệu có tác dụng ngăn cản miễn dịch có thể làm giảm đáp ứng miễn dịch với Menactra.

Thiếu hụt bổ thể

Ở những người bị chắc chắn thiếu hụt bổ thể và những người đang được điều trị ức chế phóng xạ bổ sung (ví dụ: eculizumad) có nguy cơ gia tăng bệnh xâm lấn do *N. Meningitidis*, bao gồm bệnh xâm lấn gây ra bởi nhóm huyết thanh týp A, C, Y và W-135, ngay cả khi họ phát triển các kháng thể sau khi tiêm chủng Menactra.

Giới hạn tính hiệu lực của Vắc-xin

Menactra có thể không bảo vệ cho tất cả các đối tượng được tiêm ngừa.

Ngất

Ngất (bất tỉnh) đã được báo cáo sau khi tiêm chủng với Menactra. Cần có sẵn các quy trình đề phòng thương tích do té ngã và xử trí phản ứng ngất.

SỬ DỤNG VẮC-XIN CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Tóm tắt nguy cơ

Tất cả phụ nữ mang thai đều có nguy cơ bị dị dạng bào thai, sẩy thai hoặc hệ quả khác. Theo thống kê dân số Hoa Kỳ, ước tính cơ bản của dị tật bẩm sinh và sẩy thai trong thai kỳ được công nhận trên lâm sàng tương ứng với 2% đến 4% và 15% đến 20%. Các nghiên cứu chưa đầy đủ về việc sử dụng Menactra trên phụ nữ có thai tại Hoa Kỳ. Dữ liệu sẵn có cho thấy tỷ lệ bẩm sinh và sẩy thai ở phụ nữ được sử dụng Menactra 30 ngày trước khi mang thai hoặc trong thai kỳ là phù hợp với tỷ lệ cơ bản được ước tính. Nghiên cứu độc tính đã được thực hiện trên chuột cái ở liều 0,1 ml (đã chia liều) của Menactra trước khi cho giao phối và trong thời kỳ đầu thai nghén (liều đơn ở người là 0,5 ml). Nghiên cứu cho thấy không có bằng chứng gây hại cho thai nhi khi sử dụng Menactra (xem dữ liệu trên động vật).

Dữ liệu trên người

Ghi nhận ở phụ nữ mang thai trong khoảng thời gian 11 năm (từ 2005 đến 2016), có 222 báo cáo đã sử dụng Menactra từ 30 ngày trước hoặc bất kỳ thời điểm nào trong thời kỳ mang thai. Trong số các báo cáo này, 87 báo cáo được ghi nhận tình trạng mang thai trước khi tiến hành tiêm chủng và kết quả sau tiêm chủng. Kết quả trong số những trường hợp thai phụ được giám sát này có 2 trường hợp thai nhi bị dị tật bẩm sinh nặng và 6 trường hợp sẩy thai.

Dữ liệu trên động vật

Nghiên cứu độc tính phát triển được thực hiện trên chuột cái. Động vật thử nghiệm được tiêm 0,1 ml Menactra (liều đã chia) tại mỗi thời điểm sau: 14 ngày trước khi giao phối, vào ngày thứ 6 và ngày thứ 18 của thai kỳ (liều duy nhất 0,5 ml). Không có mối liên quan đến dị tật hoặc biến thể của thai nhi và vắc-xin và không có cảnh báo tác dụng phụ nào trên sự cai sữa được quan sát theo nghiên cứu.

Phụ nữ cho con bú

Sự phát triển và lợi ích về sức khỏe trong quá trình cho con bú nên được xem xét dựa theo các báo cáo lâm sàng của Menactra và bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra trong quá trình cho con bú sau khi sử dụng Menactra.

Chưa có dữ liệu đánh giá đầy đủ của Menactra trên sự sản xuất sữa, tiết sữa và trong quá trình cho con bú.

Trẻ nhỏ

Không sử dụng Menactra cho trẻ dưới 9 tháng tuổi. Các dữ liệu nghiên cứu cho thấy có sự giảm đáp ứng với mỗi týp huyết thanh của vắc-xin não mô cầu khi tiêm 3 liều Menactra tại các thời điểm 2, 4 và 6 tháng tuổi so với các liều tiêm ở tháng tuổi thứ 9 và 12.

Người cao tuổi

Tính an toàn và hiệu quả sử dụng của Menactra ở người lớn trên 55 tuổi chưa được thực hiện .

ẢNH HƯỞNG CỦA VẮC-XIN LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của vắc-xin lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA VẮC-XIN

Không được trộn chung Menactra với bất kỳ vắc-xin nào trong cùng một bơm tiêm. Khi tiêm các vắc-xin đồng thời thì phải tiêm ở các vị trí khác nhau.

Sử dụng đồng thời với các vắc-xin khác

Vắc-xin Menactra có thể tiêm đồng thời với vắc-xin Polysaccharide Vi thương hàn (Typhim Vi®) và vắc-xin uốn ván, giải độc tố bạch hầu hấp phụ (Td) ở liều người lớn từ 18 đến 55 tuổi và từ 11 đến 17 tuổi, theo thứ tự. Ở trẻ em từ 4 đến 6 tuổi, Menactra được sử dụng đồng thời với vắc-xin DAPTACEL.

Ở bệnh nhân dưới 2 tuổi, vắc-xin Menactra được sử dụng đồng thời với một hoặc các vắc-xin sau: PCV7, MMR, V, MMRV, hoặc HepA (xem mục *Dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng* và mục *Tác dụng không mong muốn*)

Ở trẻ em từ 4 đến 6 tuổi, có thể tiêm đồng thời vắc-xin Menactra và vắc-xin DAPTACEL cùng một lúc hoặc tiêm vắc-xin Menactra trước khi tiêm vắc-xin DAPTACEL. Đáp ứng kháng thể thấp hơn đáng kể trên 4 nhóm huyết thanh Não mô cầu được ghi nhận khi tiêm Menactra sau khi tiêm vắc-xin DAPTACEL. Dữ liệu chưa được ghi nhận đầy đủ trong đánh giá đáp ứng miễn dịch ở việc sử dụng vắc-xin Menactra sau vắc-xin DAPTACEL ở trẻ nhỏ hoặc sử dụng vắc-xin Menactra cho trẻ < 11 tuổi sau các vắc-xin chứa độc tố bạch hầu khác.

Đáp ứng kháng thể đối với một số týp huyết thanh của vắc-xin Phế cầu PVC7 bị giảm khi sử dụng đồng thời Menactra và PCV7 (xem mục *Sử dụng đồng thời với các vắc-xin khác*)

Liệu pháp ức chế miễn dịch: Nếu sử dụng vắc-xin trên người đang điều trị ức chế miễn dịch, có thể không đạt được đáp ứng miễn dịch mong muốn.

Tương kỵ

Không được trộn chung Menactra với bất kỳ vắc-xin nào trong cùng một bơm tiêm. Khi tiêm Menactra đồng thời với các vắc-xin khác thì phải sử dụng tách riêng các bơm tiêm và tiêm ở các vị trí khác nhau.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng bất lợi gặp phải khi sử dụng vắc-xin.

Dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng

Vì các thử nghiệm lâm sàng được thực hiện dưới những điều kiện rất khác nhau, nên tỉ lệ phản ứng bất lợi ghi nhận được trong các thử nghiệm lâm sàng của một vắc-xin không thể so sánh trực tiếp với tỉ lệ

phản ứng bất lợi trong thử nghiệm lâm sàng của một vắc-xin khác và có thể không phản ánh tỉ lệ phản ứng bất lợi quan sát được trong thực hành.

Các nghiên cứu trên đối tượng 9 tháng đến 12 tháng tuổi

Tính an toàn của Menactra được đánh giá qua bốn nghiên cứu lâm sàng trên 3.721 đối tượng tham gia tại các thời điểm tiêm chủng Menactra lúc 9 và 12 tháng tuổi. Tại thời điểm 12 tháng tuổi, các trẻ được tiếp nhận một hoặc nhiều loại vắc-xin được khuyến cáo khác [Vắc-xin virus sống Sởi, Quai bị, Rubella và Varicella (MMRV) hoặc Vắc-xin virus Sởi, Quai bị, và Rubella (MMR) và Vắc-xin virus sống Varicella (V); các chế phẩm này do Merck & Co., Inc. sản xuất, hay vắc-xin phế cầu khuẩn liên hợp 7 giá trị (Protein bạch hầu CRM197) do Wyeth Pharmaceuticals Inc. sản xuất (PCV7); Vắc-xin viêm gan A (HepA) do Merck & Co., Inc. sản xuất].

Một nhóm đối chứng gồm 997 trẻ em ở thời điểm 12 tháng được tiếp nhận hai hoặc nhiều loại vắc-xin dành cho trẻ em là [MMRV (hoặc MMR + V), PCV7, HepA] tại thời điểm 12 tháng tuổi [xem phần *Sử dụng đồng thời với các vắc-xin khác*]. 3% trong số các đối tượng tham gia được tiêm vắc-xin MMR và vắc-xin V, thay vì vắc-xin MMRV tại thời điểm 12 tháng.

Một nghiên cứu về tính an toàn khác là một thử nghiệm có đối chứng trên 1.256 trẻ em được tiêm Menactra ở thời điểm 9 và 12 tháng tuổi. Tại thời điểm 12 tháng tuổi, những đứa trẻ này đã tiêm vắc-xin MMRV (hoặc MMR + V), PCV7 và HepA. Một nhóm đối chứng khác gồm 522 trẻ đã tiêm vắc-xin MMRV, PCV7 và HepA. Trong số 1.778 trẻ em, có 78% đối tượng được thu nhận tại các trung tâm ở Hoa Kỳ (US) (Menactra, N = 1.056; nhóm đối chứng, N = 322) và 22% đối tượng được thu nhận tại một trung tâm ở Chile (Menactra, N = 200; nhóm đối chứng, N = 200).

Đối Tượng từ 2 đến 55 tuổi

Tính an toàn của Menactra đã được đánh giá qua tám nghiên cứu lâm sàng trên 10.057 đối tượng tham gia trong độ tuổi từ 2-55 tuổi được tiêm Menactra và 5.266 đối tượng tham gia khác được tiêm Menomune® - A/C/Y/W-135, là vắc-xin Polysaccharide não mô cầu nhóm A, C, Y và W-135 phối hợp. Không có sự khác biệt đáng kể về đặc điểm nhân khẩu học giữa các nhóm sử dụng vắc-xin.

Trong số các đối tượng từ 2-55 tuổi được tiêm vắc-xin Menactra, lần lượt có 24,0%, 16,2%, 40,4% và 19,4% tương ứng các nhóm tuổi 2-10 tuổi, 11-14 tuổi, 15-25 và 26-55 tuổi. Trong số các đối tượng từ 2-55 tuổi lần lượt có 42,3%, 9,3%, 30,0% và 18,5% tương ứng các nhóm tuổi 2-10 tuổi, 11-14 tuổi, 15-25 và 26-55 tuổi được tiêm vắc-xin Menomune® - A/C/Y/W-135.

Ba nghiên cứu về tính an toàn là các thử nghiệm ngẫu nhiên, thử nghiệm có đối chứng, các nghiên cứu này đã thu nhận các đối tượng tham gia lần lượt từ 2-10 tuổi (Menactra, N = 1.713; Menomune® - A/C/Y/W-135, N = 1.519), 11-18 tuổi (Menactra, N = 2.270; Menomune®- A/C/Y/W-135, N = 972) và 18-55 tuổi (Menactra, N = 1.384; Menomune®- A/C/Y/W-135, N = 1.170). Trong số 3.232 trẻ em từ 2-10 tuổi, có 68% số đối tượng tham gia đã được thu nhận tại các trung tâm ở Hoa Kỳ (Menactra, N = 1.164; Menomune®-A/C/Y/W-135, N = 1.031) và 32% số đối tượng tham gia đã được thu nhận tại một trung tâm ở Chile (Menactra, N = 549; Menomune®-A/C/Y/W-135, N = 488). Độ tuổi trung bình của các nhóm đối tượng nhỏ này ở Chile và Hoa Kỳ lần lượt là 5 và 6 tuổi. Tất cả các đối tượng thanh thiếu niên và người lớn đều được thu nhận tại các trung tâm ở Hoa Kỳ. Do đường dùng của hai loại vắc-xin khác nhau (Menactra được chỉ định theo đường tiêm bắp, Menomune®-A/C/Y/W-135 được chỉ định

theo đường tiêm dưới da), nên nhân viên nghiên cứu thu thập dữ liệu về tính an toàn không phải là nhân viên tiêm vắc-xin.

Nghiên cứu về liều tiêm nhắc

Trong một nghiên cứu mở rộng được thực hiện ở Hoa Kỳ, 834 người tham gia được nhận 1 liều đơn Menactra 4-6 năm sau liều cơ bản . Tuổi trung bình của người tham gia nghiên cứu là 17,1 tuổi tại thời điểm tiêm nhắc.

Đánh Giá Tính An Toàn

Người tham gia được theo dõi các phản ứng xảy ra từ 20 phút đến 30 phút sau mỗi lần tiêm chủng tùy thuộc vào mỗi nghiên cứu. Các phản ứng toàn thân và tại chỗ dự kiến được ghi nhận trong sổ theo dõi 7 ngày liên tục sau mỗi lần tiêm chủng.

Đối với các biến cố bất lợi ngoài dự kiến, người tham gia được theo dõi trong 28 ngày (30 ngày đối với trẻ sơ sinh và trẻ chập chững biết đi) sau tiêm chủng. Đối với các biến cố bất lợi nghiêm trọng, các lần khám tại phòng cấp cứu hoặc các lần khám ngoài dự kiến của người tham gia được theo dõi trong 6 tháng sau tiêm chủng.

Thông tin về các biến cố bất lợi ngoài dự kiến được ghi nhận bằng cách phỏng vấn qua điện thoại hoặc tại một phòng khám lâm sàng tạm thời. Thông tin liên quan đến các biến cố bất lợi xảy ra trong khoảng thời gian 6 tháng sau khi tiêm chủng được thu nhận từ cuộc phỏng vấn qua điện thoại .

Các biến cố bất lợi nghiêm trọng trong tất cả nghiên cứu an toàn

Các biến cố bất lợi nghiêm trọng (SAE) được báo cáo trong 6 tháng sau tiêm chủng ở người tham gia từ 9 tháng tuổi đến 55 tuổi. Ở những đứa trẻ đã tiêm Menactra vào thời điểm 9 tháng và 12 tháng tuổi, các SAE đã xảy ra với tỉ lệ 2,0% - 2,5%. Ở các đối tượng tham gia đã được tiêm một hoặc nhiều loại vắc xin dùng cho trẻ em (không sử dụng Menactra đồng thời) ở thời điểm 12 tháng tuổi, các SAE đã xảy ra với tỷ lệ 1,6% - 3,6%, tùy thuộc vào số lượng và loại vắc-xin đã tiếp nhận. Ở những trẻ từ 2-10 tuổi, SAE xảy ra với tỷ lệ 0,6% và 0,7% tương ứng lần lượt với Menactra và Menomune®-A/C/Y/W-135. Ở thanh thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi và người lớn từ 18 đến 55 tuổi, SAE xảy ra với tỷ lệ là 1,0% và 1,3% tương ứng lần lượt với sau khi sử dụng Menactra và Menomune®-A /C/Y/W-135. Ở thanh thiếu niên và người lớn, SAE xảy ra với tỷ lệ 1,3% sau khi tiêm nhắc vắc-xin Menactra.

Các biến cố bất lợi trong dự kiến ghi nhận được trong các nghiên cứu tính an toàn.

Các phản ứng bất lợi toàn thân và tại chỗ trong dự kiến thường được báo cáo trong vòng 7 ngày sau tiêm chủng ở trẻ từ 9 tháng đến 12 tháng tuổi *(Bảng 1)* thường gặp nhất là nhạy chỗ tiêm và cáu kỉnh.

Các phản ứng bất lợi toàn thân và tại chỗ trong dự kiến thường được báo cáo nhất ở trẻ em Hoa Kỳ từ 2 đến 10 tuổi *(Bảng 2)* là đau tại vị trí tiêm và cáu kỉnh. Tiêu chảy, ngủ gà và chán ăn cũng thường xảy ra.

Các phản ứng bất lợi toàn thân và tại chỗ dự kiến thường được báo cáo nhất sau khi tiêm liều đơn ở thanh thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi *(Bảng 3)*, và ở các đối tượng trưởng thành từ 18 đến 55 tuổi *(Bảng 4)* là đau tại vị trí tiêm, đau đầu và mệt mỏi. Ngoại trừ đỏ tại vị trí tiêm xảy ra ở các đối tượng trưởng thành, thì các phản ứng khác tại vị trí tiêm sau tiêm chủng Menactra thường xuyên được báo cáo hơn Menomune®-A /C/Y/W-135.

Bảng 1: Báo cáo các phản ứng bất lợi trong dự kiến trong vòng 7 ngày sau tiêm chủng sau khi sử dụng vắc-xin ở thời điểm 9 tháng và 12 tháng

	Menactra ở thời điểm 9 tháng tuổi N[d]=998 – 1.002			Menactra + PCV7[a]+ MMRV[b] + HepA[c] ở thời điểm 12 tháng tuổi N[d]=898 - 908			PCV7[a] + MMRV[b] + HepA[c] ở thời điểm 12 tháng tuổi N[d]=302 - 307		
Phản ứng	**Bất kỳ**	**Mức độ 2**	**Mức độ 3**	**Bất kỳ**	**Mức độ 2**	**Mức độ 3**	**Bất kỳ**	**Mức độ 2**	**Mức độ 3**
Tại chỗ/Tại vị trí tiêm									
Đau[e]									
Vị trí tiêm Menactra	37.4	4.3	0.6	48.5	7.5	1.3	-	-	-
Vị trí tiêm PCV7	-	-	-	45.6	9.4	1.6	45.7	8.3	0.3
Vị trí tiêm MMRV	-	-	-	38.9	7.1	1.0	43.0	5.2	0.0
Vị trí tiêm HepA	-	-	-	43.4	8.7	1.4	40.9	4.6	0.3
Đỏ[f]									
Vị trí tiêm Menactra	30.2	2.5	0.3	30.1	1.3	0.1	-	-	-
Vị trí tiêm PCV7	-	-	-	29.4	2.6	0.2	32.6	3.0	0.7
Vị trí tiêm MMRV	-	-	-	22.5	0.9	0.3	33.2	5.9	0.0
Vị trí tiêm HepA	-	-	-	25.1	1.1	0.0	26.6	0.7	0.0
Sưng[f]									
Vị trí tiêm Menactra	16.8	0.9	0.2	16.2	0.9	0.1	-	-	-
Vị trí tiêm PCV7	-	-	-	19.5	1.3	0.4	16.6	1.3	0.7
Vị trí tiêm MMRV	-	-	-	12.1	0.4	0.1	14.1	0.3	0.0
Vị trí tiêm HepA	-	-	-	16.4	0.7	0.2	13.5	0.0	0.3
Toàn thân									
Kích ứng[g]	56.8	23.1	2.9	62.1	25.7	3.7	64.8	28.7	4.2
Khóc bất thường[h]	33.3	8.3	2.0	40.0	11.5	2.4	39.4	10.1	0.7
Lơ mơ[i]	30.2	3.5	0.7	39.8	5.3	1.1	39.1	5.2	0.7
Mất cảm giác ngon miệng khi ăn[j]	30.2	7.1	1.2	35.7	7.6	2.6	31.9	6.5	0.7
Nôn[k]	14.1	4.6	0.3	11.0	4.4	0.2	9.8	2.0	0.0
Sốt[l]	12.2	4.5	1.1	24.5	11.9	2.2	21.8	7.3	2.6

[a] PCV7 (Prevnar®) = Vắc-xin phế cầu khuẩn liên hợp 7 giá trị.

[b] MMRV (ProQuad®) = Vắc-xin virus sống Sởi, Quai bị, Rubella và Varicella dạng kết hợp.

[c] HepA (VAQTA®) = Vắc-xin viêm gan A, dạng bất hoạt.

[d] N = Số đối tượng tham gia mà dữ liệu có thể sử dụng được.

[e] Mức độ 2: Khóc và phản kháng khi bị chạm vào vị trí tiêm.

Nguồn: USPI_CBER_ngày 26/04/2018

Mức độ 3: Khóc khi làm dịch chuyển chi đã được tiêm, hoặc cử động của chi đã được tiêm bị giảm đi.

[f] Mức độ 2: ≥ 1.0 inches đến <2.0 inches; Mức độ 3: ≥ 2.0 inches.

[g] Mức độ 2: Cần được tăng cường chú ý thêm; Mức độ 3: Khóc suốt không thôi.

[h] Mức độ 2: 1 đến 3 giờ; Mức độ 3: > 3 giờ.

[i] Mức độ 2: Không chú ý đến xung quanh hoặc không thức dậy để uống sữa/ăn; Mức độ 3: Ngủ trong suốt phần lớn thời gian hoặc rất khó thức giấc.

[j] Mức độ 2: Bỏ hoàn toàn 1 hoặc 2 cữ uống sữa/ăn; Mức độ 3: Không chịu uống sữa/ăn ≥ 3 cữ hoặc hầu hết các cữ.

[k] Mức độ 2: 2 đến 5 lần trong 24 giờ; Mức độ 3: ≥ 6 lần trong 24 giờ hoặc cần bù nước bằng đường tiêm.

[l] Mức độ 2: > 38,5°C đến ≤ 39,5°C; Mức độ 3: > 39,5°C.

Bảng 2: Tỷ lệ phần trăm đối tượng tham gia ở Hoa Kỳ từ 2 đến 10 tuổi báo cáo các phản ứng bất lợi trong dự kiến ghi nhận trong vòng 7 ngày sau tiêm chủng

	Menactra N[a]=1.156 – 1.157			**Menomune® – A/C/Y/W-135** N[a]=1.027		
Phản ứng	**Bất kỳ**	**Mức độ 2**	**Mức độ 3**	**Bất kỳ**	**Mức độ 2**	**Mức độ 3**
Tại chỗ/Tại vị trí tiêm						
Đau[b]	45.0	4.9	0.3	26.1	2.5	0.0
Đỏ[c]	21.8	4.6	3.9	7.9	0.5	0.0
Nốt cục[c]	18.9	3.4	1.4	4.2	0.6	0.0
Sưng[c]	17.4	3.9	1.9	2.8	0.3	0.0
Toàn thân						
Kích ứng[d]	12.4	3.0	0.3	12.2	2.6	0.6
Tiêu chảy[e]	11.1	2.1	0.2	11.8	2.5	0.3
Lơ mơ[f]	10.8	2.7	0.3	11.2	2.5	0.5
Chán ăn[g]	8.2	1.7	0.4	8.7	1.3	0.8
Đau cơ[h]	6.8	0.5	0.2	5.3	0.7	0.0
Sốt[i]	5.2	1.7	0.3	5.2	1.7	0.2
Phát ban[j]	3.4	-	-	3.0	-	-
Nôn[k]	3.0	0.7	0.3	2.7	0.7	0.6
Co giật[l]	0.0	-	-	0.0	-	-

[a] N = Tổng số đối tượng tham gia báo cáo ít nhất một phản ứng dự kiến. Độ tuổi trung bình của các đối tượng tham gia là 6 tuổi trong cả hai nhóm sử dụng vắc-xin

[b] Mức độ 2: Các hoạt động bình thường bị gây trở ngại

Mức độ 3: Mất khả năng hoạt động, không muốn cử động cánh tay.

[c] Mức độ 2: 1.0 - 2.0 inches; Mức độ 3: > 2.0 inches.

[d] Mức độ 2: Kéo dài 1-3 giờ; Mức độ 3: Kéo dài > 3 giờ.

[e] Mức độ 2: 3-4 lần; Mức độ 3: ≥ 5 lần.

[f] Mức độ 2: Các hoạt động bình thường bị gây trở ngại; Mức độ 3: Mất khả năng hoạt động, không muốn tham gia trò chơi hoặc tương tác với những người khác.

[g] Mức độ 2: Bỏ 2 bữa ăn; Mức độ 3: bỏ ≥ 3 bữa ăn.

[h] Mức độ 2: Giảm mức độ vận động do đau hoặc khó chịu; Mức độ 3: không thể vận động các khớp chính do đau.

[i] Nhiệt độ tương đương được đo ở miệng; Mức độ 2: 38,4°C đến 39,4°C; Mức độ 3: ≥ 39,5°C.

[j] Các biến cố bất lợi có thể chủ động thu thập này chỉ cần được báo cáo là có hoặc không xảy ra.

[k] Mức độ 2: 2 lần; Mức độ 3: ≥ 3 lần.

Ghi chú: Trong quá trình nghiên cứu mức độ 1, mức độ 2, và mức độ 3 được thu thập lần lượt tương ứng với mức độ nhẹ, trung bình, và nặng.

Bảng 3: Tỷ lệ phần trăm đối tượng tham gia từ 11 đến 18 tuổi báo cáo các phản ứng bất lợi trong dự kiến được ghi nhận trong vòng 7 ngày sau tiêm một liều vắc-xin.

	Menactra N[a]=2264 - 2265			**Menomune® – A/C/Y/W-135** N[a]=970		
Phản ứng	**Bất kỳ**	**Mức độ 2**	**Mức độ 3**	**Bất kỳ**	**Mức độ 2**	**Mức độ 3**
Tại chỗ/Tại vị trí tiêm						
Đau[b]	59.2[c]	12.8[c]	0.3	28.7	2.6	0.0
Nốt cục[d]	15.7[c]	2.5[c]	0.3	5.2	0.5	0.0
Đỏ[d]	10.9[c]	1.6[c]	0.6[c]	5.7	0.4	0.0
Sưng[d]	10.8[c]	1.9[c]	0.5[c]	3.6	0.3	0.0
Toàn thân						
Đau đầu[e]	35.6[c]	9.6[c]	1.1	29.3	6.5	0.4
Mệt mỏi[e]	30.0[c]	7.5	1.1[c]	25.1	6.2	0.2
Khó chịu[e]	21.9[c]	5.8[c]	1.1	16.8	3.4	0.4
Đau khớp[e]	17.4[c]	3.6[c]	0.4	10.2	2.1	0.1
Tiêu chảy[f]	12.0	1.6	0.3	10.2	1.3	0.0
Chán ăn[g]	10.7[c]	2.0	0.3	7.7	1.1	0.2
Ớn lạnh[e]	7.0[c]	1.7[c]	0.2	3.5	0.4	0.1
Sốt[h]	5.1 [c]	0.6	0.0	3.0	0.3	0.1
Nôn[i]	1.9	0.4	0.3	1.4	0.5	0.3
Phát ban[j]	1.6	-	-	1.4	-	-
Co giật[j]	0.0	-	-	0.0	-	-

[a] N = Số lượng đối tượng tham gia mà dữ liệu có thể sử dụng được.

[b] Mức độ 2: Chuyển động bình thường của cánh tay bị gây cản trở hoặc bị giới hạn

Mức độ 3: Mất khả năng hoạt động, không muốn vận động cánh tay.

[c] Nghĩa là Mức ý nghĩa $p < 0,05$. Giá trị p được tính toán cho từng loại phản ứng và mức độ nặng bằng cách sử dụng phép kiểm chứng Chi bình phương

[d] Mức độ 2: 1.0 - 2.0 inches, Mức độ 3: > 2.0 inches.

[e] Mức độ 2: Các hoạt động bình thường bị gây cản trở; Mức độ 3: Cần được nghỉ ngơi trên giường.

[f] Mức độ 2: 3-4 lần; Mức độ 3: ≥ 5 lần.

[g] Mức độ 2: Bỏ 2 bữa ăn; Mức độ 3: Bỏ ≥ 3 bữa ăn.

[h] Nhiệt độ tương đương được đo ở miệng; Mức độ 2: 38,5°C đến 39,4°C; Mức độ 3: ≥ 39,5°C.

[i] Mức độ 2: 2 lần; Mức độ 3: ≥ 3 lần.

[j] Các biến cố bất lợi có thể chủ động thu thập này chỉ cần được báo cáo là có hoặc không xảy ra

Ghi chú: Trong quá trình nghiên cứu mức độ 1, mức độ 2, và mức độ 3 được thu thập lần lượt tương ứng với mức độ nhẹ, trung bình, và nặng.

Bảng 4: ***Tỷ lệ phần trăm đối tượng tham gia từ 18 đến 55 tuổi báo cáo các phản ứng bất lợi trong dự kiến được ghi nhận trong vòng 7 ngày sau tiêm một liều vắc-xin.***

	Menactra N[a]=1.371			Menomune® – A/C/Y/W-135 N[a]=1.159		
Phản ứng	**Bất kỳ**	**Mức độ 2**	**Mức độ 3**	**Bất kỳ**	**Mức độ 2**	**Mức độ 3**
Tại chỗ/tại vị trí tiêm						
Đau[b]	53.9[c]	11.3[c]	0.2	48.1	3.3	0.1
Nốt cục[d]	17.1[c]	3.4[c]	0.7[c]	11.0	1.0	0.0
Đỏ[d]	14.4	2.9	1.1[c]	16.0	1.9	0.1
Sưng[d]	12.6[c]	2.3[c]	0.9[c]	7.6	0.7	0.0
Toàn thân						
Đau đầu[e]	41.4	10.1	1.2	41.8	8.9	0.9
Mệt mỏi[e]	34.7	8.3	0.9	32.3	6.6	0.4
Khó chịu[e]	23.6	6.6[c]	1.1	22.3	4.7	0.9
Đau khớp[e]	19.8[c]	4.7[c]	0.3	16.0	2.6	0.1
Tiêu chảy[f]	16.0	2.6	0.4	14.0	2.9	0.3
Chán ăn[g]	11.8	2.3	0.4	9.9	1.6	0.4
Ớn lạnh[e]	9.7[c]	2.1[c]	0.6[c]	5.6	1.0	0.0
Nôn[h]	2.3	0.4	0.2	1.5	0.2	0.4
Sốt[i]	1.5[c]	0.3	0.0	0.5	0.1	0.0
Phát ban[j]	1.4	-	-	0.8	-	-
Co giật[j]	0.0	-	-	0.0	-	-

[a] N = Số lượng đối tượng tham gia mà dữ liệu có thể sử dụng được

[b] Mức độ 2: Chuyển động bình thường của cánh tay bị gây cản trở hoặc bị giới hạn

Mức độ 3: Mất khả năng hoạt động, không muốn vận động cánh tay.

[c] Nghĩa là Mức ý nghĩa $p < 0,05$. Giá trị p được tính toán cho từng loại phản ứng và mức độ nặng bằng cách sử dụng phép kiểm chứng chi bình phương.

[d] Mức độ 2: 1.0 - 2.0 inches; Mức độ 3: > 2.0 inches.

[e] Mức độ 2: Các hoạt động bình thường bị gây cản trở; Mức độ 3: Cần được nghỉ ngơi trên giường

[f] Mức độ 2: 3 - 4 lần; Mức độ 3: ≥ 5 lần

[g] Mức độ 2: Bỏ 2 bữa ăn; Mức độ 3: bỏ ≥ 3 bữa ăn

[h] Mức độ 2: 2 lần; Mức độ 3: ≥ 3 lần

[i] Nhiệt độ tương đương được đo ở miệng; Mức độ 2: 39,0°C to 39,9°C; Mức độ 3: ≥ 40,0°C

[j] Các biến cố bất lợi có thể chủ động thu thập này chỉ cần được báo cáo là có hoặc không xảy ra

Ghi chú: Trong quá trình nghiên cứu mức độ 1, mức độ 2 và mức độ 3 được thu thập lần lượt tương ứng với mức độ nhẹ, trung bình, và nặng.

Dữ liệu các biến cố bất lợi trong dự kiến được ghi nhận khi tiêm liều nhắc vắc-xin Menactra.

Xem phần *Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu ở liều tiêm nhắc* để biết thông tin về mô tả thiết kế nghiên cứu và số lượng đối tượng tham gia. Các phản ứng toàn thân và tại chỗ trong dự kiến được ghi nhận trong vòng 7 ngày sau tiêm chủng được báo cáo thường xuyên nhất là đau (60,2%) và đau cơ (42,8%).

Nói chung, tỷ lệ các phản ứng toàn thân và tại chỗ trong dự kiến là tương đương với dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng ghi nhận được ở thiếu niên và người lớn sau tiêm một liều Menactra. Đa số các phản ứng trong dự kiến này ở mức độ 1 và 2 và tự khỏi trong vòng 3 ngày.

Các biến cố bất lợi được nghiên cứu khi tiêm đồng thời với các vắc-xin khác.

Các phản ứng toàn thân và tại vị trí tiêm dự kiến khi tiêm với các vắc-xin thông thường khác ở trẻ em.

Để biết mô tả thiết kế nghiên cứu và số người tham gia, xem mục *Dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng* và mục *Sử dụng đồng thời với các vắc-xin khác*. Trong nghiên cứu an toàn, 1.378 trẻ em Mỹ đã tiêm Menactra lúc 9 tháng tuổi và tiêm Menactra cùng với một hoặc nhiều loại vắc-xin thông thường khác (MMRV, PCV7 và HepA) ở thời điểm 12 tháng tuổi (N = 961). Một nhóm trẻ khác nhận được hai hay nhiều loại vắc-xin thông thường khác (MMRV, PCV7 và HepA) (nhóm đối chứng, n = 321) lúc 12 tháng tuổi. Tần số xuất hiện các tác dụng không mong muốn được trình bày trong *Bảng 1*. Các phản ứng nhạy tại vị trí tiêm, đỏ và sưng được báo cáo thường xuyên trên các đối tượng tiêm Menactra cùng lúc với các vắc-xin thông thường khác.

Nhạy chỗ tiêm là phản ứng thường gặp nhất tại vị trí tiêm (tương ứng lần lượt 48,0%; 39,0%; 46,0% và 43,0% cho Menactra, MMRV, PCV7 và HepA). Cáu kỉnh là phản ứng toàn thân thường gặp nhất, được báo cáo với tỷ lệ 62,0% người tiêm Menactra đồng thời với vắc-xin khác và với 65,0% trên nhóm đối chứng (xem mục *Sử dụng đồng thời với các vắc-xin khác*).

Trong một nhóm ngẫu nhiên, song song, thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm của Hoa Kỳ được tiến hành trên trẻ em từ 4 đến 6 tuổi, Menactra được dùng như sau: Nhóm A, Menactra được tiêm sau 30 ngày sau khi tiêm vắc-xin DAPTACEL®; vắc-xin hấp phụ, giải độc tố uốn ván, ho gà vô bào-giải độc tố bạch hầu giảm hàm lượng (DTaP), sản xuất bởi Sanofi Pasteur và vắc-xin bất hoạt Poliovirus IPOL®, sản xuất bởi Sanofi Pasteur. Nhóm B, Menactra sử dụng đồng thời với vắc-xin DAPTACEL®, 30 ngày sau khi tiêm IPV; Nhóm C, Menactra sử dụng đồng thời với IPV, 30 ngày sau khi tiêm vắc-xin DAPTACEL®.

Các phản ứng toàn thân và tại vị trí tiêm dự kiến được ghi nhận trên thẻ nhật ký trong vòng 7 ngày sau mỗi lần tiêm chủng. Các báo cáo thường gặp là đau tại chỗ tiêm tương ứng lần lượt 52,2%; 60,9% và 56,0% trên tất cả các nhóm nghiên cứu A, B và C. Đau cơ là phản ứng toàn thân cũng được ghi nhận trong các báo cáo với tỷ lệ 24,2%; 37,3% và 26,7% tương ứng với các nhóm đối tượng A, B và C. Sốt > 39,5°C xảy ra dưới 1,0% ở tất cả các nhóm.

Các phản ứng toàn thân và tại vị trí tiêm dự kiến khi tiêm vắc-xin hấp phụ, uốn ván và giải độc tố bạch hầu (Td)

Trong nghiên cứu lâm sàng, tỷ lệ phản ứng tại chỗ và toàn thân sau khi tiêm Menactra và vắc-xin hấp phụ, uốn ván và giải độc tố bạch hầu (Td), sản xuất bởi Sanofi Pasteur, đã được so sánh. Đau tại vị trí tiêm được báo cáo thường xuyên hơn sau khi tiêm vắc-xin Td so với Menactra (71,0% so với 53,0%). Khi dùng đồng thời vắc-xin Td và Menactra, tỷ lệ các tác dụng không mong muốn cao hơn khi tiêm riêng lẻ Menactra và vắc-xin Td (59,0% so với 36,0%). Trên cả hai nhóm, các phản ứng thường gặp là đau đầu (Menactra + vắc-xin Td là 36,0%; Vắc-xin Td + Giả dược là 34,0%; Menactra đơn độc 22,0%) và mệt mỏi (Menactra + vắc-xin Td là 32,0%; Vắc-xin Td + Giả dược là 29,0%; Menactra đơn độc 17,0%). Sốt ≥ 40,0° C xảy ra ≤ 0,5% trên tất cả các nhóm.

Các phản ứng toàn thân và tại vị trí tiêm dự kiến khi tiêm vắc-xin Polysaccharide Vi thương hàn (Typhim Vi®)

Trong nghiên cứu lâm sàng, tỷ lệ phản ứng tại chỗ và toàn thân sau khi tiêm Menactra và vắc-xin Polysaccharide Vi thương hàn (Typhim Vi®), sản xuất bởi Sanofi Pasteur, đã được so sánh. Đa số các đối tượng tham gia có phản ứng đau với vắc-xin Typhim Vi® nhiều hơn Menactra (Typhim Vi® + Giả dược là 76,0% so với Menactra + Typhim Vi® là 47,0%). Phần lớn (70,0% - 77,0%) các phản ứng tại vị trí tiêm trên cả hai nhóm được báo cáo ở mức độ 1 và tự khỏi trong vòng 3 ngày sau tiêm chủng.
Trên cả hai nhóm, phản ứng toàn thân thường gặp nhất là đau đầu (Menactra + Typhim Vi® là 41,0%; Typhim Vi® + Giả dược là 42,0%; tiêm Menactra đơn độc 33,0%) và mệt mỏi (Menactra + Typhim Vi® là 38,0%; Typhim Vi® + Giả dược là 35,0%; tiêm Menactra đơn độc 27,0%). Sốt ≥ 40,0° C và các tai biến không có báo cáo trên cả hai nhóm.

<u>Dữ liệu giám sát hậu mãi</u>

Ngoài các báo cáo trong thử nghiệm lâm sàng, các báo cáo về phản ứng có hại của các tình nguyện viên trên toàn thế giới đã được ghi nhận rộng rãi được liệt kê dưới đây kể từ khi Menactra được cấp phép lưu hành. Danh sách này được ghi nhận dựa trên mức độ và tần suất nghiêm trọng của các phản ứng có hại xảy ra có mối liên quan tới vắc-xin Menactra. Do các biến cố này được báo cáo từ một nhóm dân số ngẫu nhiên, do đó không thể ước tính một cách đáng tin cậy về tần suất cũng như thiết lập mối tương quan tới việc chủng ngừa.

Rối loạn hệ máu và bạch huyết

Bệnh bạch huyết.

Rối loạn hệ miễn dịch

Các phản ứng quá mẫn như phản vệ/phản ứng phản vệ, thở rít, khó thở, phù nề đường hô hấp trên, mề đay, đỏ, ngứa, hạ huyết áp.

Rối loạn hệ thần kinh

Hội chứng Guillain-Barré, dị cảm, ngất mạch-phế vị, hoa mắt, co giật, liệt mặt, viêm não-tủy rải rác cấp tính, viêm tủy cắt ngang.

Rối loạn cơ xương khớp và mô liên kết
Đau cơ.

Rối loạn toàn thân và rối loạn tại chỗ tiêm
Các phản ứng tại chỗ tiêm lan rộng, kể cả sưng chi lan xa đã được báo cáo. Các phản ứng này có thể kèm với hồng ban, nóng, nhạy đau chỗ tiêm hay đau tại chỗ tiêm.

Nghiên cứu an toàn hậu mãi

Nguy cơ GBS sau khi tiêm Menactra đã được đánh giá trong một nghiên cứu thuần tập hồi cứu tại Hoa Kỳ sử dụng dữ liệu bảo hiểm y tế từ 9.578.688 người từ 11 đến 18 tuổi, trong đó có 1.431.906 người (15%) đã tiêm Menactra. Trong 72 trường hợp GBS được khẳng định trên bệnh án, không có trường hợp nào đã tiêm Menactra trong vòng 42 ngày trước khi khởi phát triệu chứng. Có thêm 129 trường hợp GBS tiềm tàng không thể khẳng định hoặc loại trừ vì không có hoặc không đủ thông tin trong bệnh án. Trong một phân tích có xét đến dữ liệu bị thiếu, các ước lượng nguy cơ quy thuộc của GBS trên người từ 11 đến 18 tuổi dao động từ 0 đến 5 trường hợp GBS cộng thêm trên 1.000.000 người được tiêm vắc-xin trong giai đoạn 6 tuần sau sau tiêm chủng.

Báo cáo các phản ứng bất lợi đáng ngờ

Việc báo cáo các phản ứng bất lợi đáng ngờ sau khi sản phẩm thuốc được cấp phép lưu hành là rất quan trọng. Điều này cho phép tiếp tục theo dõi cân bằng lợi ích/nguy cơ của sản phẩm thuốc. Nhân viên y tế được yêu cầu báo cáo mọi phản ứng bất lợi nghi ngờ qua hệ thống báo cáo quốc gia đến Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc theo địa chỉ email: di.pvcenter@gmail.com

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Không có dữ liệu về sử dụng vắc-xin quá liều, không dùng quá liều chỉ định của vắc-xin.
Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược lý-trị liệu: vắc-xin não mô cầu.

Mã ATC: J07AH08: kháng nguyên polysaccharide tinh chế não mô cầu tứ giá cộng hợp.

Bệnh do nhiễm Não mô cầu bao gồm viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn *N. meningitidis* gây ra; mà một số nhóm huyết thanh đã được nhận diện. Menactra có thể đem lại sự bảo vệ chống nhiễm khuẩn do các nhóm huyết thanh A, C, Y và W-135 gây ra.

Tính sinh miễn dịch

Menactra tạo ra sự sản xuất kháng thể đặc hiệu với các polysaccharide vỏ của tất cả các nhóm huyết thanh trong vắc-xin (A, C, Y và W-135), có khả năng giết chết vi khuẩn tương ứng. Tính sinh miễn dịch đã được đánh giá bằng cách đo những kháng thể chức năng này trong một xét nghiệm huyết thanh diệt khuẩn (SBA) sử dụng huyết thanh của thỏ con (SBA-BR) hoặc của người (SBA-HC) làm nguồn bổ thể.

Tính sinh miễn dịch trên quần thể trẻ em từ 9 đến 12 tháng tuổi
Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên, đa trung tâm tiến hành tại Hoa Kỳ, trẻ em từ 9 đến 12 tháng tuổi được tiêm vắc-xin Menactra. Tiêm đơn độc Menactra ở liều đầu tiên, ở liều thứ hai kế tiếp có thể tiêm đơn độc Menactra (n=404) hoặc tiêm MMR (n=302) hoặc tiêm PCV7 (n=422). Huyết thanh được lấy sau 30 ngày trên tất cả các đối tượng, không có sự khác biệt đáng kể về đặc điểm nhân khẩu học giữa các nhóm tiêm vắc-xin. Độ tuổi trung bình cho liều tiêm Menactra đầu tiên là từ 278-279 ngày tuổi.

Liều dùng và phác đồ của Menactra trên trẻ nhỏ từ 12 đến 15 tháng tuổi đã được đánh giá tại Hoa Kỳ. Trước khi tiến hành tiêm liều đầu tiên, 33,3% (n=16/48) đối tượng có hiệu giá kháng thể SBA-H ≥1: 8 cho huyết thanh týp A, và 0-2% (n=0-1 của 50-51) cho các huyết thanh týp C, Y và W-135. Sau liều tiêm thứ 2, phần trăm các đối tượng với hiệu giá kháng thể ≥1: 8 lần lượt tương ứng 85,2% cho huyết thanh týp A (n=46/54); 100% huyết thanh týp C (n=54/54); 96,3% huyết thanh týp Y (n=52/54); 96,2% huyết thanh týp W-135 (n=50/52).

Tính sinh miễn dịch trên quần thể từ 2 đến 55 tuổi

Tính sinh miễn dịch đã được đánh giá so sánh trên 3 nhóm, ngẫu nhiên, tại Hoa Kỳ, đa trung tâm với các hoạt động kiểm soát lâm sàng liên quan đến trẻ em (từ 2 đến 10 tuổi), thanh thiếu niên (11 đến 18 tuổi) và người lớn (18 đến 55 tuổi). Các đối tượng được tiêm liều đơn Menactra (N=2526) hoặc Menomune® – A/C/Y/W-135 (N=2317). Huyết thanh được đo ở ngày thứ 28 sau tiêm chủng trên tất cả các nhóm đối tượng.

Trong mỗi thử nghiệm, không có sự khác biệt đáng kể về đặc điểm nhân khẩu học giữa các nhóm tiêm vắc-xin, giữa tính sinh miễn dịch hoặc nghiên cứu dân số tổng thể. Trong nghiên cứu trên trẻ em từ 2 đến 10 tuổi, độ tuổi trung bình là 3 tuổi, có 95% hoàn thành nghiên cứu. Trong nghiên cứu ở thanh thiếu niên, độ tuổi trung bình cho cả 2 nhóm là 14 tuổi, có 99% hoàn thành nghiên cứu. Trong nghiên cứu ở người lớn, độ tuổi trung bình là 24 tuổi, có 94% hoàn thành nghiên cứu.

Tính sinh miễn dịch trên quần thể trẻ em từ 2 đến 10 tuổi

Trên 1.408 trẻ em tuổi từ 2 đến 10 tuổi, đáp ứng miễn dịch được đánh giá so sánh trên 4 nhóm huyết thanh giữa các đối tượng sử dụng Menactra (từ 2 đến 3 tuổi, n=53; từ 4 đến 10 tuổi, n=84) và đối tượng sử dụng Menomune®-A/C/Y/W-135 (từ 2 đến 3 tuổi, n=53; 4 đến 10 tuổi, n=84).

Ở các đối tượng tham gia từ 2 đến 3 tuổi với hiệu giá kháng thể bằng 0 trước khi tiêm (hiệu giá SBA-H <1:4 tại Ngày 0), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh (được định nghĩa là tỷ lệ của người tham gia với hiệu giá SBA-H ≥1: 8 ở Ngày 28) tương tự giữa các đối tượng tiêm Menactra và đối tượng tiêm Menomune®-A/C/Y/W-135. Các đối tượng tiêm Menactra đạt tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh là: 57% huyết thanh nhóm A (n = 12/21); 62% huyết thanh nhóm C (n = 29/47); 84% huyết thanh nhóm Y (n = 26/31); 53% huyết thanh nhóm W-135 (n = 20/38). Tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh ở các đối tượng tiêm Menomune®-A/C/Y/W-135 là: 55% huyết thanh nhóm A (n = 16/29); 30% huyết thanh nhóm C (n = 13/43); 57% huyết thanh nhóm Y (n = 17/30); 26% huyết thanh nhóm W-135 (n = 11/43).

Ở các đối tượng tham gia từ 4 đến 10 tuổi với hiệu giá kháng thể bằng 0 trước khi tiêm chủng (hiệu giá SBA-H <1:4 tại Ngày 0), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh (được định nghĩa là tỷ lệ của người tham gia với hiệu giá SBA-H ≥1: 8 ở Ngày 28) tương tự giữa các đối tượng tiêm Menactra và đối tượng tiêm Menomune®-A/C/Y/W-135. Các đối tượng tiêm Menactra đạt tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh là: 69% huyết thanh nhóm A (n = 11/16); 81% huyết thanh nhóm C (n = 50/62); 98% huyết thanh nhóm Y (n = 45/46); 69% huyết thanh nhóm W-135 (n = 27/39). Tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh ở các đối tượng tiêm Menomune®-A/C/Y/W-135 là: 48% huyết thanh nhóm A (n = 10/21); 38% huyết thanh nhóm C (n = 19/50); 84% huyết thanh nhóm Y (n = 38/45); 68% huyết thanh nhóm W-135 (n = 26/38).

Tính sinh miễn dịch trên quần thể thiếu niên 11 đến 18 tuổi

Kết quả so sánh thử nghiệm lâm sàng được thực hiện trên 881 thanh thiếu niên tuổi từ 11 đến 18 cho thấy rằng đáp ứng miễn dịch của Menactra và Memomune®-A/C/Y/W-135 là tương tự như nhau trên 4 nhóm huyết thanh.

Ở các đối tượng tham gia với hiệu giá kháng thể bằng 0 trước khi tiêm chủng (hiệu giá SBA-H <1:8 tại Ngày 0), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh (được định nghĩa là tỷ lệ của người tham gia với hiệu giá SBA-BR tăng gấp 4 lần ở Ngày 28) tương tự giữa các đối tượng tiêm Menactra và đối tượng tiêm Menomune® - A/C/Y/W-135. Các đối tượng tiêm Menactra đạt tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh là: 100% huyết thanh nhóm A (n = 81/81); 99% huyết thanh nhóm C (n = 153/155); 98% huyết thanh nhóm Y (n = 60/61); 98% huyết thanh nhóm W-135 (n = 161/164). Tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh ở các đối tượng tiêm Menomune® - A/C/Y/W-135 là: 100% huyết thanh nhóm A (n = 93/93); 38% huyết thanh nhóm C (n = 151/152); 100% huyết thanh nhóm Y (n = 47/47); 99% huyết thanh nhóm W-135 (n = 138/139).

Tính sinh miễn dịch trên quần thể 18 đến 55 tuổi

Kết quả so sánh thử nghiệm lâm sàng được thực hiện trên 2.554 người trưởng thành tuổi từ 18 đến 55 tuổi cho thấy đáp ứng miễn dịch của Menactra và Memomune®-A/C/Y/W-135 được xem là tương tự trên 4 nhóm huyết thanh.

Ở các đối tượng tham gia với hiệu giá kháng thể bằng 0 trước khi tiêm chủng (hiệu giá SBA-H <1:8 tại Ngày 0), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh (được định nghĩa là tỷ lệ của người tham gia với hiệu giá SBA-BR tăng gấp 4 lần ở Ngày 28) tương tự giữa các đối tượng nhận Menactra và đối tượng nhận Menomune®-A/C/Y/W-135. Các đối tượng tiêm Menactra đạt tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh là: 100% huyết thanh nhóm A (n = 156/156); 99% huyết thanh nhóm C (n = 343/345); 91% huyết thanh nhóm Y (n = 253/279); 97% huyết thanh nhóm W-135 (n = 360/373). Tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh ở các đối tượng Menomune®-A/C/Y/W-135 là: 99% huyết thanh nhóm A (n = 143/144); 98% huyết thanh nhóm C (n = 279/304); 97% huyết thanh nhóm Y (n = 211/228); 99% huyết thanh nhóm W-135 (n = 325/328).

Tính sinh miễn dịch trên quần thể thanh thiếu niên và người trưởng thành ở liều tiêm nhắc lại

Trước khi tiến hành tiêm nhắc, tỷ lệ phần trăm của người tham gia (n=781) với hiệu giá SBA-H ≥1: 8 lần lượt là 64,5%, 44,2%, 38,7%, và 68,5% tương ứng với các nhóm huyết thanh týp A/C/Y/W-135. Trong số những người tham gia thử nghiệm (n = 112), có đáp ứng SBA-H tại Ngày 6 đã được đánh giá, 86,6%, 91,1%, 94,6% và 92,0% tương ứng các nhóm huyết thanh A/C/Y và W-135 với hiệu giá SBA-H tăng gấp 4 lần. Tỷ lệ người tham gia (n = 781) đạt được mức tăng ≥ 4 lần trong chuẩn SBA-H vào Ngày 28 là 95,0%, 95,3%, 97,1% và 96% tương ứng lần lượt cho các nhóm huyết thanh týp A/C/Y/W-135. Tỷ lệ các đối tượng đạt được hiệu giá SBA-H ≥ 1: 8 vào Ngày 28 là > 99% cho mỗi nhóm huyết thanh.

<u>Động học đáp ứng miễn dịch</u>

Không có dữ liệu về động học của đáp ứng ban đầu với Menactra, nhưng như các vắc-xin polysaccharide và cộng hợp khác, sau tiêm vắc-xin khoảng 7 đến 10 ngày đạt được sự bảo vệ.

<u>Hiệu lực</u>

Tính đáp ứng của vắc-xin được đánh giá dựa vào hiệu giá kháng thể SBA-H của 1:8 hoặc lớn hơn cho mỗi nhóm huyết thanh khi tiến hành tiêm 2 liều cách nhau vào thời điểm 9 tháng tuổi và 12 tháng tuổi ở trẻ nhỏ và một liều ở trẻ từ 2 đến 10 tuổi.

Trên đối tượng từ 11 đến 55 tuổi, tính đáp ứng của vắc-xin với liều đơn duy nhất được đánh giá dựa trên hiệu giá kháng thể SBA-BR gấp 4 lần ở mỗi týp huyết thanh.

Đối với các đối tượng từ 2 đến 55 tuổi, hiệu lực của vắc-xin sau một liều duy nhất được đánh giá bằng SBA trong chứng minh tương đương miễn dịch với vắc-xin viêm màng não cầu khuẩn Menomune®-A/C/Y/W-135 được cấp phép tại Hoa Kỳ (xem *"Tính sinh miễn dịch học"*)

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Chưa có nghiên cứu dược động học nào được thực hiện.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Lọ 1 liều 0,5 ml. Hộp 1 lọ.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản ở 2°C đến 8°C (35°F đến 46°F) (trong tủ lạnh). **KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ĐÔNG BĂNG.**
Để xa tầm tay trẻ em.

TUỔI THỌ

24 tháng ở nhiệt độ 2°C đến 8°C kể từ ngày sản xuất lọ vắc-xin.

HẠN DÙNG

Không được dùng vắc-xin sau ngày hết hạn sử dụng được ghi trên nhãn sau chữ "E".

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn cơ sở

THÔNG TIN TƯ VẤN BỆNH NHÂN

Trước khi tiêm vắc-xin Menactra, nhân viên y tế nên cung cấp thông tin cho người định tiêm vắc xin, cha mẹ, người giám hộ, hoặc một người lớn có trách nhiệm về những lợi ích và nguy cơ tiềm tàng đối với bệnh nhân [xem **BIẾN CỐ BẤT LỢI và CẢNH BÁO, THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG**]. Phải hướng dẫn người định tiêm vắc xin, cha mẹ hoặc người giám hộ báo cáo những Tác dụng không mong muốn đáng ngờ cho nhân viên y tế, và nhân viên y tế sẽ báo cáo những biến cố này cho Sanofi Pasteur qua địa chỉ email: pharmacovigilance.vietnam@sanofi.com và/ hoặc hệ thống báo cáo quốc gia đến Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc theo địa chỉ email: di.pvcenter@gmail.com

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT/ ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH

SANOFI PASTEUR

Trụ sở chính: 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon – Pháp.

Sản xuất bởi: SANOFI PASTEUR INC.
Discovery Drive
Swiftwater PA 18370
Hoa Kỳ

Phiên bản: 26/04/2018

SANOFI PASTEUR

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy